

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор  
Департамента лекарственных  
средств и медицинских изделий при  
Министерстве здравоохранения  
Кыргызской Республики  
Бекбоев В.Т.  
« 13 » \_\_\_\_\_ 2025 г.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

### НЕБИВЕГА

**Торговое название**

Небивега

**Международное непатентованное название**

Небиволол

**Лекарственная форма**

Таблетки для приёма внутрь

**Состав**

Каждая таблетка содержит:

*Активное вещество:*

Небиволола гидрохлорид экв. небивололу - 5 мг

*Вспомогательные вещества:*

лактоза/лактоза моногидрат, микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал, кроскар-меллоза натрия, кремния диоксид коллоидный безводный, повидон К-30, кукурузный крахмал для пасты, магния стеарат, очищенный тальк/тальк, натрия крахмалгликолят (Тип-А), кроскар-меллоза натрия, кремния диоксид коллоидный безводный.

**Описание**

Непокрытые таблетки белого цвета, круглые, плоские, с риской на одной стороне.

**Фармакотерапевтическая группа**

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Бета-адреноблокаторы. Бета-адреноблокаторы селективные. Небиволол.

**Код АТХ:** C07AB12

**Фармакологическое действие**

**Фармакодинамика**

Небиволол кардиоселективный липофильный бета<sub>1</sub>-адреноблокатор III поколения с вазодилатирующими свойствами. Оказывает гипотензивное, антиангинальное и антиаритмическое действие. Снижает повышенное АД в покое, при физическом напряжении и стрессе. Конкурентно и избирательно блокирует синаптические и постсинаптические бета<sub>1</sub>-адренорецепторы, делая их недоступными для катехоламинов, модулирует высвобождение

эндотелиального вазодилатирующего фактора оксида азота (NO).

Небиволол представляет собой рацемат, состоящий из двух энантиомеров: SRRR-небиволола (D-небиволола) и RSSS-небиволола (L-небиволола), сочетающий два фармакологических действия:

1) D-небиволол является конкурентным и высокоселективным блокатором бета<sub>1</sub>-адренорецепторов (сродство к бета<sub>1</sub>-адренорецепторам в 293 раза выше, чем к бета<sub>2</sub>-адренорецепторам);

2) L-небиволол оказывает мягкое сосудорасширяющее действие за счет модуляции высвобождения релаксирующего фактора (NO) из эндотелия сосудов.

Гипотензивный эффект развивается на 2-5-й день лечения, стабильное действие отмечается через 1 месяц. Антигипертензивный эффект сохраняется при длительном лечении.

Гипотензивное действие обусловлено также уменьшением активности ренин-ангиотензиновой системы (прямо не коррелирует с изменением активности ренина в плазме крови).

Применение небиволола улучшает показатели системной и внутрисердечной гемодинамики. Невиволол урежает ЧСС и АД в покое и при физической нагрузке, уменьшает конечное диастолическое давление левого желудочка, снижает ОПСС, улучшает диастолическую функцию сердца (снижает давление наполнения), увеличивает фракцию выброса.

Снижая потребность миокарда в кислороде (урежение ЧСС, снижение преднагрузки и постнагрузки), уменьшает количество и тяжесть приступов стенокардии и повышает переносимость физической нагрузки.

Антиаритмическое действие обусловлено подавлением патологического автоматизма сердца (в т.ч. в патологическом очаге) и замедлением АВ-проводимости.

#### **Фармакокинетика**

После приема внутрь небиволол быстро абсорбируется из ЖКТ. Прием пищи не влияет на абсорбцию, поэтому небиволол можно принимать независимо от приема пищи. Биодоступность составляет в среднем 12% у пациентов с «быстрым» метаболизмом и является почти полной у пациентов с «медленным» метаболизмом. Эффективность небиволола не зависит от скорости метаболизма.

Клиренс в плазме крови у большинства пациентов (с «быстрым» метаболизмом) достигается в течение 24 ч, а для гидроксиметаболитов - через несколько суток. Концентрации в плазме крови 1-30 мкг/л пропорциональны дозе.

Связывание с белками плазмы крови (преимущественно с альбумином) для D-небиволола составляет 98,1%, а для L-небиволола — 97,9%.

Небиволол активно метаболизируется, частично с образованием активных гидроксиметаболитов. Скорость метаболизма небиволола путем ароматического гидроксирования генетически определена окислительным полиморфизмом и зависит от изофермента CYP2D6.

Через неделю после введения 38% (количество неизмененного активного вещества составляет менее 0,5%) дозы выводится почками и 48% - через кишечник. У пациентов с «быстрым» метаболизмом значения  $T_{1/2}$  энантиомеров небиволола из плазмы крови составляют в среднем 10 ч. У пациентов с «медленным» метаболизмом эти значения в 3-5 раз увеличиваются.

У пациентов с «быстрым» метаболизмом значения  $T_{1/2}$  гидроксиметаболитов обоих энантиомеров из плазмы крови составляют в среднем 24 ч, у пациентов с «медленным» метаболизмом эти значения приблизительно в 2 раза увеличиваются.

На фармакокинетику небиволола не влияет возраст и пол пациентов.

#### **Показания к применению**

- артериальная гипертензия;
- хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной терапии).

#### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к составу препарата;
- выраженные нарушения функции печени;
- острая сердечная недостаточность;
- хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации (требующая ВВ введения препаратов, обладающих инотропным эффектом);
- кардиогенный шок;
- синдром слабости синусового узла, включая синоаурикулярную блокаду;
- АВ-блокада II и III степени (без искусственного водителя ритма);
- бронхоспазм и бронхиальная астма;
- нелеченая феохромоцитома;
- метаболический ацидоз;
- выраженная брадикардия (ЧСС менее 50 уд. /мин);
- выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.);
- тяжелые облитерирующие заболевания периферических сосудов (перемежающаяся хромота, синдром Рейно);
- миастения;
- возраст до 18 лет;

- непереносимость лактозы, дефицит лактазы или синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы. С *осторожностью* следует назначать препарат при почечной недостаточности, сахарном диабете, гиперфункции щитовидной железы, аллергических заболеваниях в анамнезе, псориазе, АВ-блокаде I степени, стенокардии Принцметала, хронической обструктивной болезни легких, пациентам старше 65 лет.

#### *Беременность и период лактации:*

Небиволол может оказать отрицательное воздействие на течение беременности, плод и новорожденного. Уменьшение перфузии плаценты под действием бета-адреноблокаторов может вызвать задержку развития плода, внутриутробную смерть плода, выкидыш или преждевременные роды. У плода и новорожденного ребенка могут наблюдаться брадикардия, артериальная гипотензия, гипогликемия. Если лечение бета-адреноблокаторами необходимо, то следует отдать предпочтение бета1-селективным бета-адреноблокаторам.

Применение препарата Небивега при беременности возможно только в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Назначение препарата при беременности возможно только по строгим показаниям. Если лечение небивололом необходимо, следует проводить наблюдение за маточно-плацентарным кровотоком и ростом плода.

Прием препарата необходимо прекратить за 48-72 ч до родов. В тех случаях, когда это невозможно, необходимо обеспечить строгое наблюдение за новорожденными в течение 48-72 ч после родов.

Исследования на животных показали, что небиволол выделяется с грудным молоком. При необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

#### **Способ применения и дозы**

Таблетки принимают внутрь в одно и то же время суток независимо от приема пищи, таблетки можно делить пополам и на четыре одинаковые части (но не разжевывать) и запивать жидкостью.

*Артериальная гипертензия.* Средняя суточная доза составляет 5 мг (1 таблетка) в один прием. Оптимальный эффект становится выраженным через 1-2 недели лечения, а в ряде случаев - через 4 недели. Возможно применение препарата в монотерапии или в составе комбинированной терапии. Дополнительный гипотензивный эффект наблюдался при комбинированном применении небиволола 5 мг с 12,5-25 мг гидрохлортиазида.

*У больных с почечной недостаточностью, а также у пациентов в возрасте старше 65 лет*

начальная доза составляет 2,5 мг (1/2 таблетки) в один прием. При необходимости дозу увеличивают до 5 мг.

*Пациенты с печеночной недостаточностью*, имеются лишь ограниченные данные о применении небиволола при печеночной недостаточности или с нарушением функции печени. По этой причине применение препарата Небивега у таких пациентов противопоказано.

*Пожилые пациенты*. У пациентов старше 65 лет рекомендованная начальная суточная доза составляет 2,5 мг (1/2 таблетки). При необходимости суточная доза может быть увеличена до 5 мг.

*Хроническая сердечная недостаточность*. Лечение должно начинаться с постепенного увеличения дозы до достижения индивидуальной оптимальной поддерживающей дозы. Подбор дозы в начале лечения необходимо осуществлять по следующей схеме, выдерживая недельные интервалы и основываясь на переносимости этой дозы пациентом: доза, составляющая 1,25 мг (1/4 таблетки) 1 раз в сутки, может быть увеличена сначала до 2,5 мг - 5 мг (1/2 таблетки - 1 таблетка) в сутки в один прием, а затем - до 10 мг (2 таблетки) в сутки в один прием. Пациент должен находиться под контролем врача в течение 2 ч после приема первой дозы препарата, а также после каждого последующего увеличения дозы. Каждое увеличение дозы должно осуществляться не менее чем через 2 недели. Максимально рекомендованная доза при терапии хронической сердечной недостаточности составляет 10 мг препарата в сутки в один прием. Во время титрования рекомендуется регулярный контроль АД, ЧСС и симптомов выраженности хронической сердечной недостаточности.

Во время фазы титрации в случае ухудшения течения хронической сердечной недостаточности или непереносимости препарата рекомендуется снизить дозу препарата или в случае необходимости немедленно прекратить его прием (в случае ярко выраженной артериальной гипотензии, ухудшении течения хронической сердечной недостаточности с острым отеком легких, в случае развития кардиогенного шока, симптоматической брадикардии или АВ блокаде).

### **Побочные действия**

*Нарушения со стороны иммунной системы*: частота неизвестна: ангионевротический отек, гиперчувствительность.

*Нарушения психики*: нечасто: депрессия, «кошмарные» сновидения;

*Нарушения со стороны нервной системы*: часто: головная боль, головокружение, парестезии; очень редко: обморок.

*Нарушения со стороны органа зрения*: нечасто: нарушение зрения.

*Нарушения со стороны сердца*: нечасто: брадикардия, острая сердечная недостаточность, замедление АВ проводимости/АВ-блокада.

*Нарушения со стороны сосудов*: нечасто: выраженное снижение АД, ортостатическая гипотензия.

*Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения*: часто: одышка; нечасто: бронхоспазм.

*Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта*: часто: тошнота, запор, диарея; нечасто: диспепсия, метеоризм, рвота.

*Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей*: нечасто: кожная сыпь эритематозного характера, зуд; очень редко: усугубление течения псориаза; частота неизвестна: крапивница.

*Нарушения со стороны половых органов и молочных желез*: нечасто: эректильная дисфункция.

*Общие расстройства и нарушения в месте введения*: часто: повышенная утомляемость, отеки.

### **Передозировка**

Данных о передозировке небиволола не существует.

*Симптомы:* брадикардия, артериальная гипотензия, бронхоспазм и острая сердечная недостаточность.

*Лечение:* промывание желудка, прием активированного угля. В случае выраженного снижения АД необходимо придать пациенту горизонтальное положение с приподнятыми ногами, при необходимости ВВ введении жидкости и вазопрессоров.

При выраженной брадикардии вводят ВВ 0,5-2 мг атропина, при отсутствии положительного эффекта возможна постановка трансвенозного искусственного водителя ритма.

При АВ блокаде (II-III ст.) рекомендуется ВВ введение бета-адреномиметиков, при их неэффективности следует рассмотреть вопрос о постановке искусственного водителя ритма. При сердечной недостаточности лечение начинают с введения сердечных гликозидов и диуретиков, при отсутствии эффекта целесообразно введение допамина, добутамина или вазодилаторов. При бронхоспазме вводят ВВ бета2-адреномиметики. При желудочковой экстрасистолии - лидокаин (нельзя вводить антиаритмические средства IA класса).

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

#### *Фармакодинамические взаимодействия*

Следующие взаимодействия относятся к бета-адренергическим антагонистам в целом.

*Не рекомендованные комбинации:* При одновременном применении с антиаритмическими средствами I класса (хинидин, гидрохинидин, цибензолин, флекаинид, дизопирамид, лидокаин, мексилетин, пропафенон) возможно усиление отрицательного инотропного действия и удлинение времени проведения через атриовентрикулярный узел.

При одновременном применении  $\beta$ -адреноблокаторов с блокаторами «медленных» кальциевых каналов (БМКК) (верапамил и дилтиазем) усиливается отрицательное действие на сократимость миокарда и атриовентрикулярную проводимость. Противопоказано в/в введение верапамила на фоне приема небиволола.

При одновременном применении с гипотензивными препаратами центрального действия (клонидин, гуанфацин, моксонидин, метилдопа, рилменидин) возможно ухудшение течения сердечной недостаточности за счет снижения симпатического тонуса (снижение ЧСС и сердечного выброса, симптомы вазодилатации). В случае резкой отмены данных препаратов, особенно до отмены небиволола, возможно развитие «рикошетной» артериальной гипертензии.

#### *Комбинации, которые следует применять с осторожностью*

При одновременном применении с антиаритмическими средствами III класса (амиодарон) может усиливать влияние на время проведения через атриовентрикулярный узел.

Одновременное применение небиволола и лекарственных средств для общей анестезии может вызывать подавление рефлекторной тахикардии и увеличивать риск развития артериальной гипотензии.

Одновременное применение инсулина и гипогликемических препаратов для приема внутрь может маскировать некоторые симптомы гипогликемии (учащенное сердцебиение, тахикардия).

Одновременное применение баклофена и амифостина с гипотензивными препаратами может вызвать значительное падение артериального давления, поэтому требуется коррекция дозы гипотензивных препаратов.

#### *Комбинации, которые следует принимать во внимание*

Одновременное применение с сердечными гликозидами может вызвать замедление атриовентрикулярной проводимости. Небиволол не влияет на фармакокинетические параметры дигоксина.

Одновременное применение небиволола и БМКК дигидропиридинового ряда (амлодипин, фелодипин, лацидипин, нифедипин, никардипин, нимодипин, нитрендипин) может повышать риск возникновения артериальной гипотензии. Нельзя исключать снижения сократительной

способности миокарда у пациентов с сердечной недостаточностью.

При сочетании с гипотензивными средствами, нитроглицерином может развиваться выраженная артериальная гипотензия (особая осторожность необходима при сочетании с празозином).

Одновременное применение трициклических антидепрессантов, барбитуратов и производных фенотиазина может усиливать гипотензивное действие небиволола.

Клинически значимого взаимодействия небиволола и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) не установлено. Ацетилсалициловая кислота в качестве антиагрегантного средства может применяться одновременно с небивололом.

При одновременном применении симпатомиметические средства подавляют активность небиволола.

#### *Фармакокинетическое взаимодействие*

При одновременном применении с лекарственными средствами, ингибирующими обратный захват серотонина, или другими средствами, биотрансформирующимися с участием изофермента CYP2D6 (например, пароксетин, флуоксетин, тиоридазин, хинидин), метаболизм небиволола замедляется, повышается его концентрация в плазме крови, что может приводить к повышению риска появления выраженной брадикардии и нежелательных явлений.

При одновременном применении с циметидином возможно повышение концентрации небиволола в плазме крови без изменения клинического эффекта.

Одновременное применение ранитидина не оказывает влияния на фармакокинетические параметры небиволола.

При одновременном применении небиволола с никардипином концентрации обоих веществ в плазме крови незначительно повышаются без изменения клинического эффекта.

Одновременный приём этанола, фуросемида или гидрохлоротиазида не влиял на фармакокинетику небиволола.

Не установлено клинически значимого взаимодействия небиволола и варфарина.

#### **Особые указания**

При проведении хирургических вмешательств следует предупредить врача-анестезиолога о том, что пациент принимает небиволол.

Отмену бета-адреноблокаторов следует проводить постепенно, в течение 10 дней (до 2-х недель у пациентов с ИБС).

Контроль АД и ЧСС в начале приема препарата должен быть ежедневным. У пожилых пациентов необходим контроль функции почек (1 раз в 4-5 месяцев). При стенокардии напряжения доза препарата должна обеспечить ЧСС в покое в пределах 55-60 уд./мин, при нагрузке - не более 110 уд./мин. Бета-адреноблокаторы могут вызывать брадикардию: дозу следует снизить, если ЧСС менее 50-55 уд./мин.

При решении вопроса о применении препарата Небивега пациентам с псориазом следует тщательно соотнести предполагаемую пользу и возможный риск обострения течения псориаза.

Пациенты, пользующиеся контактными линзами, должны учитывать, что на фоне применения бета-адреноблокаторов возможно снижение продукции слезной жидкости.

Небивега не влияет на концентрацию глюкозы в плазме крови у пациентов с сахарным диабетом. Тем не менее, следует соблюдать осторожность при лечении этих пациентов, поскольку небиволол может замаскировать определённые симптомы гипогликемии (например, тахикардию), вызванные применением гипогликемических средств.

Контроль концентрации глюкозы в плазме крови следует проводить 1 раз в 4-5 месяцев (у больных с сахарным диабетом).

Бета-адреноблокаторы следует применять с осторожностью у пациентов с ХОБЛ, поскольку может усиливаться бронхоспазм.

При гиперфункции щитовидной железы препарат маскирует тахикардию.

Бета-адреноблокаторы могут повышать чувствительность к аллергенам и тяжесть анафилакти-

ческих реакций.

Эффективность бета-адреноблокаторов у курильщиков ниже, чем у некурящих пациентов. Препарат содержит лактозу, поэтому не следует применять его пациентам с непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

*Влияние на способность к управлению автомобилем и другими сложными механизмами:*

Не оказывает влияния на скорость психомоторных реакций. У некоторых пациентов могут возникать побочные эффекты, чаще всего головокружение, из-за сниженного АД. При возникновении подобных эффектов пациенту не следует управлять транспортными средствами или заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими особого внимания и быстроты психомоторных реакций. Данные эффекты возникают чаще всего сразу после начала лечения или при увеличении дозы.

#### **Форма выпуска**

10 таблеток для приёма внутрь в каждом блистере.

3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

#### **Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

По рецепту врача.

#### **Владелец торговой марки и регистрационного удостоверения**

Vegapharm LLP

Astra House, Arklow Road,

London SE14 6EB, UK (Великобритания)

#### **Производитель**

Synokem Pharmaceuticals Ltd.

Plot No. 35 & 36, Sector 6A, ПЕ,

SIDCUL, Ranipur, Distt. Haridwar-249403, Uttarakhand, India (Индия)

*Адрес организации, принимающей на территории Кыргызской Республики претензии от потребителей по качеству продукции (товара):*

ОсОО «Аман Фарм» (Аман Фарм), Республика Кыргызстан, город Бишкек,  
ул. Шоорукова 36.

Тел.: (0312) 560466, E-mail: [aman.pharm12@gmail.com](mailto:aman.pharm12@gmail.com)